FAQ перед опросом: безопасность и доверие

Если я расскажу о тяжелых мыслях, меня сразу госпитализируют?

Нет автоматической связи между одним ответом и госпитализацией. Специалист уточнит состояние и обсудит помощь. При серьезной опасности может потребоваться срочная помощь; решение принимают по клинической ситуации и закону.

Кто увидит мои ответы?

Перед отправкой сервис должен назвать медицинскую организацию, ответственного специалиста и других сотрудников, которым нужен доступ для помощи. Данные не становятся публичными. Правила и исключения конфиденциальности доступны до согласия.

Могу ли я пропустить вопрос?

Да, можно отказаться или остановиться. В вопросах безопасности есть действие «Не готов(а) отвечать» и отдельная возможность поговорить со специалистом. Отказ не будет записан как «нет»; оценка останется незавершенной.

Может ли приложение поставить диагноз?

Опросники описывают симптомы и помогают специалисту подготовиться к беседе. Диагноз и план помощи определяет квалифицированный специалист с учетом клинической оценки.

Что делать, если помощь нужна прямо сейчас?

Откройте «Мне нужна помощь сейчас». При непосредственной опасности нужна местная экстренная помощь; не ждите ответа на обычное сообщение или завершения анкеты.

Узнают ли родители или университет?

Для совершеннолетнего пользователя сервис не предусматривает автоматической отправки ответов родителям или университету. Передача сведений требует надлежащего основания. Закон предусматривает отдельные исключения из конфиденциальности; они должны быть объяснены.

Тексты адаптированы для первой версии 18+. Для несовершеннолетних необходим отдельный сценарий с проверкой правил согласия, представительства и информирования; переносить эти ответы без проверки нельзя.

Источники: [5], [7], [16], [20], [31], [32], [33].

FAQ: переживания, термины и лечение

Что такое депрессия? Это значит, что со мной что-то не так?

Депрессия - название состояния, которое может влиять на настроение, интерес к жизни, энергию и повседневные дела. Это не оценка характера. Симптомы требуют разбирательства; один результат анкеты диагнозом не является.

Обязательно ли назначат антидепрессанты?

Один балл теста не определяет лечение. Специалист обсуждает состояние, подходящие варианты, ожидаемую пользу, ограничения и ваши предпочтения. Самостоятельно начинать или менять лечение по результату приложения не нужно.

Может ли специалист осудить меня за мои мысли?

Профессиональная помощь должна быть уважительной. Можно прямо сказать, что вы боитесь реакции. Если общение задело вас, это можно обсудить или обратиться к другому специалисту.

Нужно ли рассказывать о мыслях о смерти, если я не собираюсь действовать?

Рассказать полезно и без намерения причинить себе вред: специалист сможет лучше понять переживания и обсудить поддержку. Наличие мыслей, намерение, план и действия - разные сведения.

Что делать, если мысли стали привычными?

Привычность не показывает, насколько состояние безопасно или нужна ли помощь. Можно обсудить эти мысли со специалистом, даже если они существуют давно и не стали сильнее.

Почему обращаться до ухудшения?

Поддержку можно искать до серьезных нарушений учебы, работы или отношений. Для обращения не нужно ждать, пока станет «достаточно плохо».

Что делать, если я не готов(а) отвечать откровенно?

Можно остановиться, задать вопрос о правилах или обсудить тему непосредственно со специалистом. Сервис сохраняет отказ как отказ и не делает вывод, что переживаний нет.

Различаем: мысли - содержание переживаний; намерение - готовность действовать; план - сформированные представления о действиях; поведение - совершенные или подготовительные действия. Оценка специалиста учитывает контекст и актуальность, а не только эти названия.

Источники: [3], [5], [7], [11], [16], [26], [27].

Вопрос до обследования: два разных сервиса

Модель	Как работает	Что нельзя обещать
Библиотека FAQ до регистрации	Проверенные специалистом общие ответы. Поиск по темам. Не запрашивать личную историю для простого чтения. Технические журналы описаны отдельно.	Чтение без аккаунта не гарантирует отсутствия любых технических следов.
Конфиденциальный вопрос из аккаунта	Человек выбирает специалиста и видит время ответа. Вопрос связан с аккаунтом и журналируется; публикации в общем FAQ нет.	Не называть анонимным и не выдавать обычную переписку за экстренный канал.
Отдельная анонимная очередь - версия 2	Без связи с аккаунтом; случайный код для чтения ответа; минимизация журналов и идентификаторов, отдельная проверка архитектуры. Просьба не включать ФИО и контакты в текст.	Нельзя обещать истинную анонимность без проверки логов, аналитики, адресов и содержимого вопроса. Нельзя обещать найти человека при опасности.

Нужен работающий процесс ответа

Очередь имеет ответственного, модерацию, фактическое расписание и срок ответа. До открытия формы отображаются эти сведения и указание, что канал не подходит для срочной помощи. Передача вопроса и прочтение специалистом - отдельные статусы. Анонимный вопрос не переносится автоматически в медицинскую карту.

Уточнение идеи Даны. Возможность получить ответ без раскрытия личности может снизить барьер. Это не означает сбор данных «без согласия человека». Пользователь должен понимать, что отправляет и как будет использован текст. Общий ответ на чужой вопрос можно читать без прохождения скрининга.

При сообщении об опасности специалист действует в пределах доступных сведений и протокола. Если контакт отсутствует, удаленно установить личность может быть невозможно. Такое ограничение объясняется заранее; автоматический поиск личности и обещание спасения по анонимной заявке в MVP не включаются.

Источники: [16], [20], [21], [22], [31], [32].

Согласие и конфиденциальность: содержание

Что объяснить до отправки	Что подготовить для реализации
Цель и участники	Назвать оператора, медицинскую организацию, ответственного специалиста и цель обработки каждого набора данных.
Доступ к ответам	Определить роли, основания доступа, получателей и журнал просмотров. Доступ университета как к индивидуальным результатам не предусматривается.
Хранение и передача	Зафиксировать место основных и резервных баз, сроки, обработчиков, порядок экспорта и удаления. Для данных граждан РФ проверить применимые требования ст.18 152-ФЗ.
Голос и расшифровка	Запись необязательна; показать, кто обработает аудио и текст, где они окажутся и сколько хранятся. Нельзя незаметно отправлять их внешнему ИИ-сервису.
Право отказаться и отозвать	Показать канал отзыва, последствия для дальнейшей работы и применимые основания продолжения хранения медицинской документации. Не обещать безусловное мгновенное удаление всего.
Исключения и помощь	Объяснить законные пределы конфиденциальности и процедуру при опасности. Отказ от раскрытия не равен отрицательному ответу.
Автоматизация	Описать расчет шкал; ИИ, если он появится, используется для вспомогательной работы с текстом после отдельной проверки.

Правовые ориентиры

152-ФЗ: согласие оформляется отдельно от других подтверждаемых документов; данные о здоровье относятся к специальным категориям и требуют определения надлежащего правового основания. Нельзя считать любую галочку достаточной для любого вида медицинской обработки. 323-ФЗ: врачебная тайна, согласие на медицинское вмешательство и правила медицинской помощи. Это разные вопросы, их не следует прятать в одном общем «Принимаю все».

Пределы раскрытия определяются законом и конкретной ситуацией. Приложение не дает произвольного разрешения делиться сведениями с близкими при любом положительном ответе. Для несовершеннолетних разрабатывается отдельный порядок.

До запуска заполнить реальные сведения об операторе, юридических основаниях, сроках хранения и получателях. В этом документе они не выдумываются: это открытые задачи команды и медицинского партнера.

Источники: [31], [32], [33].